

Información Paciente

Nombre : Roberto Antonio Aranda Yanez
Edad : 62a 2m 11d
Dirección : Camino Al Faro Parcela 50

Rut : 9.043.851-4
Fecha Nacto: 31/12/1959
Comuna : La Florida

N° Archivo : 1939059
Sexo : Masculino
Teléfono : 995048790

N° Epicrisis
299090

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Ingreso : 01/03/2022 04:23

Días Estadía: 10

Unidad de Egreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Egreso : 11/03/2022 17:03

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Hemorragia Subaracnoidea

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

Nombre: Roberto Antonio Aranda Yañez
Edad: 62 años
RUT: 9.043.851-4
FI UCI: 01/03/2022

Antecedentes:

Médicos: Crisis de pánico, situación de calle.

Quirúrgicos: Se desconocen

Medicamentos: Sertralina 50 mg al día (Mala adherencia)

Alergia: (-)

Inmunización COVID-19: Completa + refuerzo.

Paciente ingresa al SU CASR traído por SAMU en contexto de atropello por motocicleta.

Ingresa a reanimador grave, en ventilación espontánea, GCS 3 y discretos signos de descerebración a maniobra nociceptivo. E -FAST negativo.

Se realizó IOT con SRI y conexión a VMI.

Se tomó imágenes:

- TAC de cerebro en donde se observa HSA en convexidad parasagital, frontoparietal, interhemisférica, silviana bilateral y contenido hemático en cuerno posterior de ventrículo lateral izquierdo y en tercer ventrículo. Sin Hidrocefalia.

- TAC de Tórax informó fracturas costales en arco anterior y posterior desde la 7ma a 11va costilla no desplazadas y opacidades leves en ambos lóbulos inferiores determinadas por focos contusionales.

- TAC de Abdomen y pelvis con acentuada esteatosis hepática. Sin otros hallazgos agudos.

Ingresa a UPC para continuar manejo y seguimiento.

Diagnósticos de Ingreso UPC

- TEC severo con HSA: Convexidad parasagital, fronto parietal, interhemisfrica, hemoventriculo del lateral y tercer ventrículo, sin hidrocefalia, con FAE. Marshall III Fisher IV.

- Sd convulsivo / sin status

Fecha Epicrisis : 11/03/2022 17:25

Fecha Última Actualización: 11-03-2022 17:25:25

Página 2 de 3

- Hipernatremia severa (155)
- 04/03 HIPERTENSION ENDOCRANEANA EN CONTEXTO DE AUMENTO DE CONTUSIONES FRONTALES, en especial perisilviana izquierda con compresión de ventrículo. Línea media levemente desviada a derecha menos de 5mm.
- Colocación de PIC (retirado)
- Alcalosis respiratoria Pco2 22 Ph 7.5
- Hipokalemia leve 3.03
- Fracturas costales izq.
- Contusión pulmonar bibasales
- Alcoholismo /Sd deprivación
- Antecedentes: Depresión, HTA, asma y Diabetes (mal control y sin datos en sistema).
- Situación calle desde al menos un año
- PCR covid (-)

Paciente con interurrencias y evolución mencionadas, el día de ayer presenta PCR en ritmo de AESP. Se inician maniobras de RCP, saliendo al segundo ciclo con una ampolla de adrenalina. Ritmo de salida sinusal. Sin causa evidente por inestabilidad hemodinámica no se realizó Neuroimagen ayer, y el día de hoy con pupilas isocóricas intermedias, no reactivas, sin reflejo corneano, por mayor estabilidad se realiza TC de cerebro con Angio TC de tórax que informa.

Examen sin evidencias tomográficas de un tromboembolismo pulmonar agudo hasta el nivel segmentario.

Leve derrame pleural bilateral.

Aumento de tamaño de los focos de condensación ubicados en lóbulos inferiores, probablemente determinado por una neumopatía de etiología inflamatoria - Infecciosa.

Ateromatosis aórtica.

TC de Cerebro evaluado por Servicio de Neurocirugía: se observa edema cerebral difuso, cisternas de la base y peritroncales ausentes, herniación transtentorial y tranforamen magno.

Infartos en territorio de arterias cerebrales anteriores.

Paciente evoluciona posterior a estudio con mayor deterioro y shock refractario, en contexto de daño cerebral severo fuera de alcance de intervenciones quirúrgicas se decide tratamiento proporcional.

Evoluciona con bradicardia extrema, posterior asistolia, se constata óbito a hs 15:30 del día 11/03/2021.

Se da aviso a familiar (Hermano) .

Diagnóstico de Egreso

Hemorragia subaracnoidea traumática - Hipertension endocraneana

Condición de Egreso Fallecido

Egreso con Catéter Doble J:NO

Fallecido

Plan Post Alta

Fallecido

Indicaciones

Tipo de Reposo :

Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Controles

Fecha Epicrisis : 11/03/2022 17:25

Página 2 de 3

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 14:40

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar



Epicrisis Hospitalaria

ESTADO: DEFINITIVA



COMPLEJO ASISTENCIAL

DR. SÓTERO DEL RÍO

JUNTOS PARA UNA MEJOR SALUD

Fecha Última Actualización: 11-03-2022 17:25:25

Página 3 de 3

INTERNO

Becado/Residente

Andrea Betina Vaquera

Médico Tratante (Staff)